

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO SEP 29 26 PM 3:28
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1187

INFORME POSITIVO

29 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y análisis del Proyecto del Senado 1187, somete a este Alto Cuerpo la consideración de la medida, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1187 (en adelante, P. del S. 1187), tiene como propósito establecer la "Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto Rico", con el propósito de disponer que, ante una declaración de emergencia decretada en Puerto Rico, por motivos de salud o epidemia, todo cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para combatir esta, serán ofrecidos sin costo alguno para la ciudadanía; enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para Combatir el COVID-19", a los fines de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; facultar al Gobernador de Puerto Rico a modificar los beneficios a los que se hace referencia en los artículos 2, 3 y 4 de esta Ley; derogar la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1187 propone enmendar la Ley 43-2020 para atemperarla a la actualidad donde el COVID-19 no debe ser la única emergencia médica que la Ley cubra. Comienza enmendando el Artículo 1 de la Ley 43-2020, para que sea conocida como "Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto Rico". A su vez, pretende enmendar el Artículo 2 de la Ley 43-2020 para que ante una declaración de Emergencia de Salud o Epidemia todo cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para combatirla sean ofrecidos libres de

costos para la ciudadanía. De la misma manera se enmienda el Artículo 4 de la Ley 43-2020 sobre la prohibición de requerir copago en toda gestión dirigida a atender la emergencia de salud o epidemia.

Igualmente se propone una enmienda al Artículo 5 sobre el servicio de recobro por los proveedores de servicios para eliminar la palabra COVID-19 y uniformarlo a emergencias de salud o epidemia declarada. De manera similar se enmienda el Artículo 6 sobre la reglamentación para eliminar la especificación al COVID-19 y remover la instrucción de que dicho Reglamento será aprobado sin sujeción a la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", Ley 38-2017, según enmendada.

ALCANCE DEL INFORME

La Comision de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1187, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), Asociación Médica de Puerto Rico (AMPR), Administración de Seguros de Salud (ASES), Colegio de Médicos Cirujanos de PR (CMCPR), Departamento de Salud (DS), Oficina Comisionado de Seguro (OCS).

A pesar de reiteradas solicitudes, la siguiente entidad no compareció ante la Comision: Colegio de Médicos Cirujanos de PR (CMCPR).

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES

La Asociación de Hospitales (AHPR) no favorece la medida en sus términos actuales. La AHPR expuso que reconoce y comparte la preocupación legítima del Estado de garantizar el acceso oportuno a servicios de salud durante situaciones de emergencia o epidemias. Añaden que durante la pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de adoptar mecanismos extraordinarios para proteger la salud pública.

Sin embargo, la AHPR señala ciertas consideraciones operacionales, fiscales y estructurales que requieren ser evaluadas antes de la aprobación de esta medida. Piden se tome en consideración que los hospitales y otros proveedores de salud operan dentro de un ecosistema muy complejo y regulado, caracterizado por aumentos sostenidos en costos operacionales, limitaciones en el recurso humano clínico, presiones inflacionarias y retos significativos de liquidez.

A su juicio, este esfuerzo legislativo amplía las obligaciones de cubierta sin proveer estructuras claras y viables de financiamiento y reembolso. La AHPR indicó que, para favorecer la medida requieren ver que se establezcan mecanismos claros de financiamiento y reembolso, evaluación de sostenibilidad fiscal y operacional de las enmiendas que propone el proyecto. Además, recomienda evaluar la interacción con

programas y requisitos federales y realizar un análisis económico y operacional detallado.

La entidad enfatiza que una medida de esta magnitud debe estar respaldada por el análisis exhaustivo del impacto económico y operacional que tendrá. Hacer las investigaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de su intención legislativa. Procurar que este proyecto tenga los elementos necesarios para beneficiar a Puerto Rico a largo plazo adecuadamente.

ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO



La Asociación Médica de Puerto Rico (AMPR) recomienda que el proyecto no sea aprobado en su estado actual, sea revisado integralmente, incorpore un mecanismo de financiamiento, defina con mayor precisión el alcance de la cubierta y limite mejor la discreción administrativa. La AMPR señala que el proyecto elimina costos para los pacientes, pero no establece una fuente de financiamiento. La entidad entiende que el lenguaje utilizado en la medida es demasiado amplio. Recomendamos que el Departamento de Salud emita un listado clínico-administrativo específico al activarse una emergencia para definir los tratamientos, medicamentos, servicios hospitalarios y criterios de elegibilidad cubiertos por la ley.

La AMPR sugiere incorporar enmiendas que protejan al proveedor que incluya términos fijos de pago, entre otros elementos que salvaguarden las preocupaciones de los médicos y los hospitales. Expresa una preocupación sobre la amplia facultad que el proyecto concede al Gobernador para modificar beneficios mediante boletines administrativos. Incluso recomiendan que se lleve a cabo un análisis para medir el impacto sobre aseguradoras, hospitales, proveedores, primas, utilización de servicios, redes de salud y solvencia del sistema.

La Asociación pide que se incluyan mecanismos que aseguren liquidez y estabilidad operacional durante emergencias de salud pública, entiéndase: anticipos de pago, reembolsos acelerados, prioridad para entidades esenciales y mecanismos temporeros de estabilización para hospitales y otros proveedores. Destacan su recomendación para considerar un modelo alternativo menos amplio para que en lugar de una gratuidad universal e indefinida, contemple la eliminación automática de referidos y preautorizaciones, suspensión o limitación de copagos en áreas críticas, cubierta obligatoria de pruebas y tratamientos definidos, fondo de reembolso para pacientes sin cubierta, activación escalonada según la severidad de la emergencia. Por estas razones la AMPR aún en reconocimiento de la importancia de garantizar acceso a servicios de salud durante emergencias, no favorece la medida en su redacción actual.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD

La Administración de Seguros de Salud (ASES) favoreció el P. del S. 1187 por entender que esta establece un marco legal permanente para atender futuras emergencias de salud pública y epidemias en Puerto Rico. La agencia destacó que la propuesta garantizaría el acceso libre de costo a servicios clínicos esenciales durante emergencias declaradas, eliminaría barreras de acceso como copagos, deducibles, referidos y preautorizaciones, y permitiría una respuesta más rápida y uniforme ante eventos epidemiológicos. Asimismo, resaltó que la medida permitiría activar de forma inmediata mecanismos de protección sin necesidad de legislación adicional cada vez que surja una emergencia de salud pública.

Desde la perspectiva económica, la agencia argumentó que, aunque la eliminación de costos compartidos puede aumentar inicialmente la utilización de servicios, la detección y tratamiento tempranos reducen complicaciones graves, hospitalizaciones prolongadas y brotes no contenidos, produciendo beneficios económicos a mediano y largo plazo. Además, destacó que el proyecto mantiene mecanismos de reembolso para proveedores y permite al Gobernador modular beneficios según las circunstancias epidemiológicas para proteger la estabilidad financiera de planes médicos, hospitales, proveedores y del Fondo General.



La ASES hace observaciones operacionales, una de ellas consiste en implementar una coordinación entre el Departamento de Salud, ASES, aseguradoras, Pharmacy Benefit Manager y proveedores para definir los servicios esenciales cubiertos según el patógeno o la severidad del evento. Añaden a sus recomendaciones resaltar la importancia de mantener mecanismos de financiamiento para garantizar la continuidad de servicios y evitar interrupciones en la disponibilidad de camas, laboratorios, medicamentos y servicios de emergencia. La entidad también favorece que los beneficios puedan ajustarse según criterios epidemiológicos tales como nivel de transmisión, severidad clínica, disponibilidad de tratamientos e impacto sobre la capacidad hospitalaria.

Finalmente, ASES indicó que la medida promovería una respuesta más eficiente y fiscalmente responsable ante futuras emergencias epidemiológicas, fortalecería la resiliencia del sistema de salud y fomentaría la equidad en el acceso a servicios médicos para la población.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico otorgó su endoso expresamente al P. del S. 1187. El DS concurre con la intención legislativa sin solicitar enmiendas. Destaca estar a favor de garantizar acceso sin costo a servicios médicos durante una emergencia de salud o epidemia. De la misma manera, ve con buenos ojos el establecer un marco legal permanente que no requiera legislación nueva para cada emergencia.

El DS sostuvo que la legislación propuesta podría facilitar la activación de mecanismos de financiamiento federal disponibles durante emergencias de salud pública, reduciendo la carga fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, fortaleciendo la

capacidad de respuesta del sistema de salud ante futuras amenazas. Por tales razones, el Departamento de Salud apoya el P. del S. 1187.

OFICINA COMISIONADO DE SEGURO

La Oficina Comisionado de Seguro (OCS) endosa expresamente la medida. La OCS señaló que Puerto Rico está expuesto constantemente a los riesgos inherentes de epidemias. Entiende que el proyecto responde a esa realidad, buscando que todas las decisiones de la Ley 43-2020 sean extensivas ante cualquier declaración de emergencias, siempre que sea causada por alguna situación de salud o epidemia, no solo en casos de COVID.

A su vez, la agencia sostuvo que la medida evitaría que el DS tenga que invertir tiempo y recursos en la emisión de órdenes administrativas cada vez que surja una nueva emergencia epidemiológica. Dado que las enmiendas propuestas decretarían que las disposiciones de la Ley 43-2020 sean aplicables automáticamente a cualquier emergencia de salud declarada. Según la OCS, ello garantizaría una respuesta más rápida y efectiva ante eventos que impactan significativamente la salud pública.

La agencia enfatizó la importancia de asegurar que los proveedores de servicios de salud cuenten con mecanismos claros y oportunos de compensación o reembolso, a fin de preservar la continuidad y disponibilidad de los servicios durante una emergencia. Igualmente comentó que la pronta prestación de servicios contribuirá a reducir complicaciones de salud, disminuyendo la probabilidad de un colapso del sistema de salud en medio de situaciones de emergencia.



La OCS recomienda considerar adecuadamente los mecanismos de financiamiento y la coordinación interagencial necesaria, especialmente con ASES para garantizar sostenibilidad y ejecución efectiva de la legislación. Le conceden deferencia a los comentarios que tenga a bien hacer el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) en atención a su peritaje sobre el asunto.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

De aprobarse el P. del S. 1187, la OPAL estima que el impacto fiscal anual sobre las organizaciones de seguros de salud, aseguradoras, administradores de beneficios de farmacia (PBMs) y terceros administradores podría oscilar entre \$264,162 ante una epidemia similar a la del dengue y entre \$6.7-\$64.0 millones en un escenario comparable al de la pandemia del COVID-19. Aunque la medida podría generar un ahorro en los gastos de bolsillo de los asegurados, también podría incrementar las primas de los planes de salud y afectar los costos operacionales y las obligaciones contributivas de las aseguradoras. **En cuanto al Gobierno de Puerto Rico, la OPAL concluye que el impacto fiscal sugiere ser mínimo, aunque no puede precisarse al presente debido a la estructura de financiamiento del Programa Medicaid y a la incertidumbre sobre el costo de atender a la población sin cubierta médica.**

En la próxima tabla se desglosan los estimados de impacto fiscal de la medida.

Tabla. Impacto fiscal del P. del S. 1187

Epidemia/Pandemia	Promedio de Casos Mensuales	Efecto Fiscal Mensual	Casos Anuales	Efecto Fiscal Anual
Dengue	282	\$21,581	3,385	\$258,976
COVID-19*	8,523	\$652,060	85,229	\$6,520,598
COVID-19^	68,354	\$5,229,527	820,245	\$62,754,322

Fuente: Elaborado por la OPAL.

Nota:

*basado en los promedios mensuales y cantidad de casos durante el año 2020.

^basado en los promedios mensuales y cantidad de casos durante el año 2022.



La OPAL también concluyó que el impacto fiscal antes descrito podría traducirse en un ahorro para los asegurados con cubierta privada al reducirse sus gastos de bolsillo por concepto de copagos. No obstante, dada la naturaleza del modelo de negocio de las aseguradoras, la medida también podría ejercer presión al alza sobre las primas de los planes de salud como respuesta al incremento en el riesgo y en los costos asumidos. Asimismo, su aprobación podría incidir sobre el flujo de efectivo de las aseguradoras, la composición de sus portafolios de inversión y los patrones de utilización de los servicios de salud. En consecuencia, estos cambios podrían reducir la contribución sobre ingresos generada por las aseguradoras. Por otra parte, el ahorro experimentado por los asegurados podría traducirse en un mayor gasto de consumo en otros bienes y servicios, lo que, a su vez, podría generar un aumento en los recaudos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que el P. del S. 1187 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 1187, según fue referido, también analizaron los comentarios recibidos por parte de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Asociación De Hospitales (AHPR), la Asociación Médica de Puerto Rico (AMPR), Oficina Comisionado De Seguro (OCS) y el Departamento de Salud (DS).

La Comision reconoce la necesidad de atemperar la ley a las necesidades actuales de salud en Puerto Rico y consideran que este esfuerzo legislativo es importante. Coincidimos en que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad potencialmente grave, pero en los últimos años, Puerto Rico ha enfrentado distintas epidemias, tales como las del dengue y la influenza, en adición a la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La medida promueve la protección de la salud y la vida de los ciudadanos, facilita el acceso a servicios esenciales durante situaciones extraordinarias y fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud ante futuras amenazas epidemiológicas.

Los memoriales recibidos reflejan un consenso en cuanto a la importancia de garantizar el acceso oportuno a servicios médicos, diagnósticos, tratamientos y hospitalización durante situaciones de emergencia. Tanto el Departamento de Salud, la Oficina del Comisionado de Seguros y la Administración de Seguros de Salud coincidieron en que la medida fortalecería la capacidad de respuesta del Estado ante futuras emergencias de salud pública, al establecer un marco legal permanente que permita activar mecanismos de protección sin necesidad de aprobar legislación adicional o emitir nuevas disposiciones cada vez que surja una situación epidemiológica que amenace la salud de la población.

Por otro lado, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y la Asociación Médica de Puerto Rico expresaron preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad fiscal y operacional de la medida. ASES presentó unas recomendaciones pertinentes para atender las preocupaciones relacionadas con el impacto operacional de la medida. La implementación de la medida debe requerir coordinación entre el Departamento de Salud, ASES, aseguradoras, PBM y proveedores para definir los servicios esenciales cubiertos según el patógeno o la severidad del evento. Se mantendrán mecanismos de financiamiento para garantizar la continuidad de servicios y evitar interrupciones. Los beneficios podrán ajustarse según criterios epidemiológicos tales como nivel de transmisión, severidad clínica, disponibilidad de tratamientos e impacto sobre la capacidad hospitalaria.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y análisis del Proyecto del Senado 1187, somete a este Alto Cuerpo la consideración de la medida, con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López

Presidente

Comisión de Gobierno

Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELÉCTRICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1187

9 de abril de 2026

Presentado por el señor *Rosa Ramos*

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Salud

LEY



Para establecer la "Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto Rico", con el propósito de disponer que, ante una declaración de emergencia decretada en Puerto Rico, por motivos de salud o epidemia, todo cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para combatir esta, serán ofrecidos sin costo alguno para la ciudadanía; enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para Combatir el COVID-19", a los fines de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; facultar al Gobernador de Puerto Rico a modificar los beneficios a los que se hace referencia en los artículos 2, 3 y 4 de esta Ley; derogar la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938; y para otros fines relacionados.

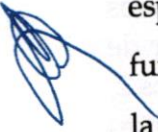
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para Combatir el COVID-19", se estableció la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el tratamiento del coronavirus; se dispuso que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento de COVID-19, incluyendo hospitalización, será libre de costo para toda la ciudadanía sin importar si cuentan o no con seguro de salud; se estableció que ninguna organización de seguros de salud, aseguradora, PBM o terceros administradores podrá requerir algún copago deducible, referido o pre autorización, por

el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incluyendo hospitalización; se permitió el pago o reembolso a los proveedores; y se dispusieron otras medidas de reglamentación e imposición de multas por su incumplimiento.

Sabemos que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Afecta principalmente al sistema respiratorio, provocando síntomas que van de leves a graves, y se propaga persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar. Comenzó a diseminarse a fines del 2019 y se convirtió en una enfermedad pandémica en el 2020.

Ciertamente, es imperativo reconocer que, el COVID-19 sigue siendo una enfermedad potencialmente grave hoy en día, especialmente para personas mayores de 65 años, bebés menores de 6 meses, embarazadas y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados o condiciones médicas crónicas (diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, etc.). Aunque la inmunidad poblacional ha reducido la severidad general, el riesgo de hospitalización sigue siendo alto en grupos vulnerables.



No obstante, los adelantos médicos han permitido la creación de tratamientos farmacológicos, aunque la mayoría de las personas se recupera de los cuadros leves espontáneamente. Para las personas que lo necesitan, se prescriben tratamientos en función de la gravedad de la enfermedad y del riesgo de que empeore, teniendo en cuenta la edad, los síntomas, otras enfermedades y otros factores individuales que puedan interferir en determinados tratamientos.

Ahora bien, en lo que a Puerto Rico respecta, nos encontramos en un nivel de transmisión bajo para el indicador de casos reportados, donde la tasa de casos reportados fue de 7.18 casos por cada 100,000 personas. El nivel más bajo de casos reportados se observó el 2 de marzo de 2026 con una tasa de 4.21 por cada 100,000 habitantes, mientras el nivel más alto se observó el 1 de febrero de 2026, con una tasa de 10.68 por cada 100,000 habitantes. Las tasas de casos reportados se observan estables, con una tasa de 4.84 casos de COVID-19 por cada 100,000 habitantes al 7 de marzo de 2026, presentando un nivel

bajo de transmisión. (Resumen Ejecutivo Situación COVID-19 en Puerto Rico/Datos Actualizados al 7 de marzo de 2026 – Departamento de Salud de Puerto Rico).

Expuesto lo anterior, es de rigor señalar que, en los últimos años, Puerto Rico ha enfrentado distintas epidemias, tales como las del dengue y la influenza, en adición a la del COVID 19. Estas epidemias provocaron que el Departamento de Salud se viera en la obligación de promulgar varias órdenes administrativas dirigidas a atender tales emergencias de salud. Entre las medidas tomadas por el Estado se encontraron ordenarles a todas las organizaciones de seguros de salud y aseguradores que suscriben planes médicos grupales individuales en Puerto Rico, planes y seguros médicos públicos y privados, a cubrir las pruebas diagnósticas del dengue; u obligar a todos los planes médicos, tanto públicos como privados, autorizar el uso de medicamentos antivirales - incluyendo oseltamivir, zanamivir, peramivir o baloxavir- para el tratamiento de la influenza en personas con síntomas compatibles, según criterio médico, sin imponer requisitos adicionales de autorización previa, solo por dar varios ejemplos.



Dicho esto, y considerando que la enfermedad del COVID 19 se encuentra en un nivel de transmisión bajo en Puerto Rico, y teniendo en cuenta lo propensos que hemos sido a enfrentar otras epidemias, entendemos apropiado revisitar y actualizar las disposiciones de la precitada Ley 43, a los efectos de renombrarla como "Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto Rico", con el propósito de disponer que, ante una declaración de emergencia decretada en Puerto Rico, por motivos de salud o epidemia, todo cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para combatir esta, serán ofrecidos sin costo alguno para la ciudadanía.

A grandes rasgos, este Ley dispone que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada, incluyendo hospitalización, será libre de costo para toda la ciudadanía sin importar si cuentan o no con seguro de salud. De igual manera, establece que ninguna organización de seguros de salud, aseguradora, PBM o terceros administradores podrá requerir algún copago, deducible, pre-autorización o referido al paciente, por cuidado

médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamiento dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada, incluyendo hospitalización, siempre y cuando estos servicios sean brindados en Puerto Rico.

Obsérvese que, esta Ley, en lugar de aplicar para casos de COVID 19, tendría efecto durante cualquier declaración de emergencia, siempre que sea causada por alguna situación de salud o epidemia. Sin embargo, reconociendo que no todas las situaciones de salud son iguales, se le confiere al Gobernador de Puerto Rico, la potestad de modificar los beneficios otorgados, en lo que respecta a las cubiertas de cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico, tratamiento dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada y hospitalización o sobre la prohibición de requerir copagos, deducibles, pre autorizaciones o referido al paciente, por cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico, tratamiento y hospitalización, en atención al comportamiento que evidencie la situación de salud o epidemia que provoque la activación de la misma. En ese sentido, el Gobernador de Puerto Rico tendría la facultad de hacer las modificaciones de rigor, para no trastocar el ecosistema económico de nuestro sistema de salud, sin necesidad.

Finalmente, es de rigor destacar que, la Asamblea Legislativa cuenta con amplios poderes para regular asuntos concernientes al bienestar de los residentes de Puerto Rico.¹ Esa facultad de la Asamblea Legislativa emana del poder público del Estado o de razón de Estado que se utiliza para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.² A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto "*poder de razón de Estado*" como "*[a]quel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad [...]*".³ Así, se desprende que el poder de razón de Estado es uno amplio; por lo que en el ejercicio del mismo, la Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar legislación dirigida a establecer

¹ Domínguez Castro, et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 44 (2010); véase, además, Defendini Collazo, et al, v. E.L.A., 134 D.P.R. 28(1993); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983); y, E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 402 (1966).

² Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-48 (1963); citando a Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27, 31 (1885); Brown v. Maryland, 12 Wheaton 419, 442 (1827); Weaver, Constitutional Law (1946), pág. 491.

³ Domínguez Castro, et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. en la pág. 36.

medidas de política pública dirigidas a atender situaciones de emergencias de salud que afecten al pueblo puertorriqueño.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
2 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

3 "Artículo 1. — Título.

4 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como ["**Ley para combatir el COVID-19**"]
5 "*Ley de Atención durante Declaraciones de Emergencias de Salud o Epidemias de Puerto*
6 *Rico*"."

7 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
8 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

9 "Artículo 2. — Declaración de Política Pública.



10 Ante [la] una Declaración de Emergencia de Salud o Epidemia, [sobre el brote de
11 coronavirus, o COVID-19, que actualmente amenaza a gran parte de la población
12 mundial,] el Gobierno de Puerto Rico establece como política pública que todo
13 cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamientos para [combatir el
14 COVID-19] combatirla serán ofrecidos en Puerto Rico sin costo alguno para la ciudadanía.
15 Al enfrentar el interés propietario de las empresas de obtener ganancias para sus
16 dueños y accionistas, con la necesidad de mantener la vida y la salud de la población,
17 ante [esta] una amenaza de salud [tan específica] a nuestra gente, el Gobierno de Puerto
18 Rico debe inclinar la balanza a favor de mantener sano a todo ser humano que habita
19 o se encuentra en nuestra jurisdicción."

1 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
2 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

3 "Artículo 3. — Obligación de cubierta.

4 Se dispone que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento
5 *dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada [de COVID-19]*, incluyendo
6 hospitalización, será libre de costo para toda la ciudadanía sin importar si cuentan o
7 no con seguro de salud."

8 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
9 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

10 "Artículo 4. — Prohibición de requerir copago.

11 Se establece que ninguna organización de seguros de salud, aseguradora, PBM o
12 terceros administradores podrá requerir algún copago, deducible, pre autorización o
13 referido al paciente, por cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico y tratamiento
14 *dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada [del COVID-19]*, incluyendo
15 hospitalización, siempre y cuando estos servicios sean brindados en Puerto Rico."

16 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
17 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

18 "Artículo 5. — Permiso de recobro por los proveedores de servicios.

19 [No obstante] Sin sujeción a lo dispuesto en los demás artículos de esta Ley, los
20 proveedores de servicios de salud, hospitales, ambulancias, laboratorios, farmacias,
21 centros de diagnóstico y tratamiento, centros de servicios primarios y demás personal
22 o empresas, que puedan percibir pagos o contratos por servicios relacionados con el

1 diagnóstico y tratamiento *dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada*
2 **[del COVID-19]**, tendrán derecho al pago y/o reembolso por parte de las
3 organizaciones de seguro de salud, aseguradoras, PBMs o terceros administradores,
4 de todos los costos relacionados con el diagnóstico y tratamiento *dirigido a atender la*
5 *emergencia de salud o epidemia declarada [del COVID-19]*, incluyendo hospitalización, y
6 *cuando aplique*, los costos del cuarto de aislamiento y los costos relacionados a la vacuna
7 que en su día se desarrolle."

8 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 43-2020, conocida como "Ley para
9 combatir el COVID-19", para que lea como sigue:

10 "Artículo 6. — Reglamentación.

11 *Cuando corresponda, el Secretario del [El] Departamento de Salud será responsable de*
12 establecer por **[reglamento un listado de]** *orden administrativa, aquellos estudios,*
13 *análisis y medicamentos necesarios para [el diagnóstico y tratamiento del COVID-*
14 *19] diagnósticos y tratamientos.*

15 *Dicha determinación se realizará en coordinación con la Administración de Seguros de*
16 *Salud, la Oficina del Comisionado de Seguros y cualquier otra entidad gubernamental*
17 *concernida, según la naturaleza de la emergencia de salud o epidemia declarada.*

18 **[Dicho Reglamento será aprobado sin sujeción a la "Ley de Procedimiento**
19 **Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", Ley 38-2017, según**
20 **enmendada.]** *El Gobernador de Puerto Rico podrá, mediante Boletín Administrativo a tales*
21 *efectos, modificar los beneficios a los que se hace referencia en los artículos 2, 3 y 4 de esta Ley,*
22 *en lo que respecta a las cubiertas de cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico, tratamiento*

1 *dirigido a atender la emergencia de salud o epidemia declarada y hospitalización o sobre la*
2 *prohibición de requerir copagos, deducibles, pre autorizaciones o referido al paciente, por*
3 *cuidado médico, estudios, análisis, diagnóstico, tratamiento y hospitalización, en atención al*
4 *comportamiento que evidencie la situación de salud o epidemia que provoque la activación de*
5 *la misma.” Al ejercer dicha facultad, el Gobernador podrá considerar factores tales como el nivel*
6 *de transmisión de la enfermedad, su severidad clínica, la disponibilidad de tratamientos o*
7 *vacunas, el impacto sobre la capacidad hospitalaria y cualquier otra consideración de salud*
8 *pública pertinente”.*

9 Sección 7.- ~~Por la presente se~~ Se deroga la Ley Núm. 157 de 10 de mayo de 1938,
10 comúnmente llamada como “Ley Sobre la Declaración de Epidemias”, así como
11 cualquier otra ley, o parte de ley, que sea incompatible con ésta.

12 Sección 8.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra
13 disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

14 Sección 9.- Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley
15 fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
16 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha
17 sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de
18 esta que así hubiere sido declarado inconstitucional.

19 Sección 10.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.